

KC桌面——外资精译

美国医疗保健服务

美国医疗保健服务

美国医疗保健服务：关于 Medicare Advantage 的专题研讨会总结

上周五，我们启动了夏季医疗保健专题研讨系列，概述了 Medicare Advantage、其历史、政策和利润影响以及未来展望（此处可观看回放，此处可查看幻灯片）。本报告总结了本次会议的关键要点。

我们将继续举办夏季专题研讨系列，下一场关于 Optum Health 的会议将于美国东部时间 6 月 18 日上午 11 点举行（[点击此处注册](#)）；

我们认为 MA 利润率在经历低谷后将出现拐点。在利润率压缩期之后，我们预计行业 MA 利润率将在 2026 年扩大约 1%，随后到 2030 年每年增长约 0.5%。这一复苏是由竞争退出、费率从 2024-25 年低点改善以及行业关注定价以实现盈利所驱动的。

MA 增长仍然持久，但正在放缓。展望未来，我们预计 MA 参保人数将以约 4-5% 的速度增长。其价值主张仍然引人注目，MA

为受益人提供增强的补充福利，并且对政府而言，其结构性成本低于 FFS。我们最终认为 MA 将占据几乎整个 Medicare 市场。

长期来看，政府 MCO 市场将趋向“公用事业化”。随着时间的推移，我们预计 MA 和 Medicaid 都将类似于公用事业市场，整合到约 4-5 家规模化参与者，并以相对适中的利润率运营（Medicaid 约 1.5%；MA 约 2-3%）。

关键颠覆因素包括 GLP-1、AI 和 VBC。GLP-1 将推高药品成本，但有可能延长寿命，从而可能将 Medicare 的可寻址市场扩大 5-10%。AI

为提高医院运营效率和患者护理水平提供了机会。随着利润率压力持续存在，VBC 将变得越来越重要，因为我们长期认为报销率将落后于医疗成本趋势约 100-150 个基点。

可负担性和可及性将成为政策辩论的焦点。政策关注点日益集中在可负担性和扩大覆盖面上。全民 Medicare 的可行性似乎不如以往周期，尤其是现在 MA 约占 Medicare 参保人数的

55%，而在此前的改革辩论中这一比例约为三分之一。我们预计民主党将推动将未参保率恢复到约 5% 的水平，而我们看到到 2028 年这一比例可能升至约 9%。

O - 跑赢大盘，M - 与大市持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：彭博社，Bernstein 估计与分析。

投资启示

我们将 AGL 评级为与大市持平，目标价 86 美元；CNC 评级为跑赢大盘，目标价 68 美元；CI 评级为跑赢大盘，目标价 371 美元；CVS 评级为跑赢大盘，目标价 106 美元；ELV 评级为跑赢大盘，目标价 424 美元；HCA 评级为与大市持平，目标价 413 美元；HUM 评级为跑赢大盘，目标价 425 美元；UNH 评级为跑赢大盘，目标价 492 美元。

详情

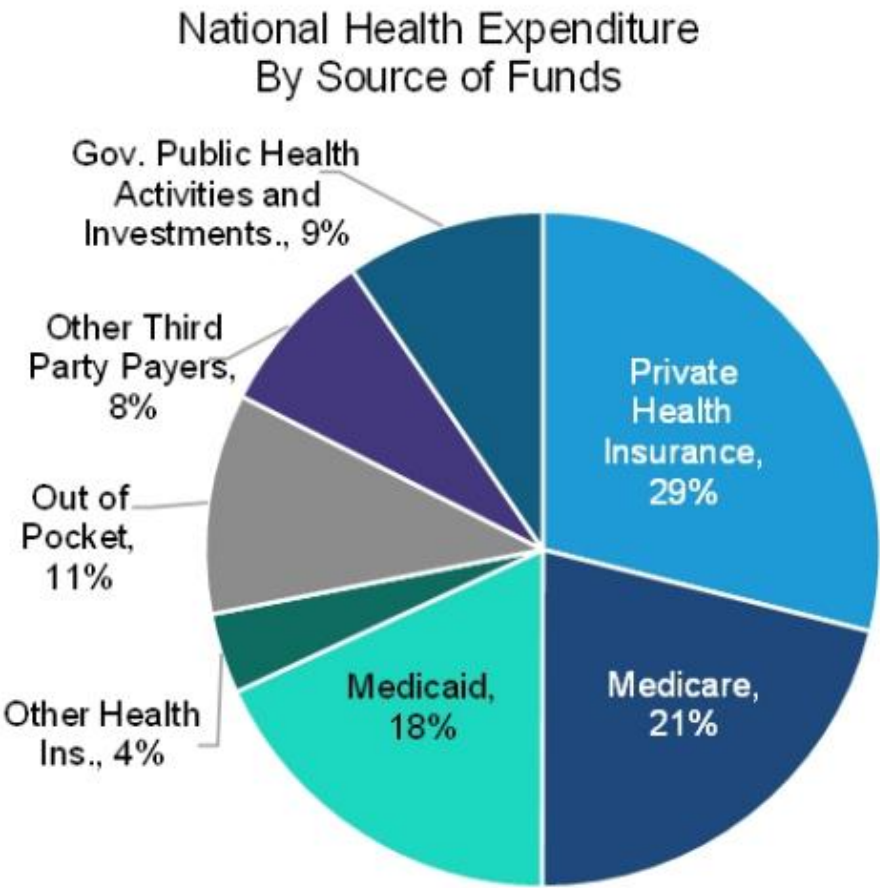
什么是 MEDICARE ADVANTAGE？

Medicare 覆盖约 20% 的人口。Medicaid 和安全网计划覆盖约 30%，雇主计划覆盖约 50%。然而，由于老年人口的医疗支出增加，Medicare 的支出金额超过了其成员比例。

图表 1：Medicare 在健康保险覆盖中的位置

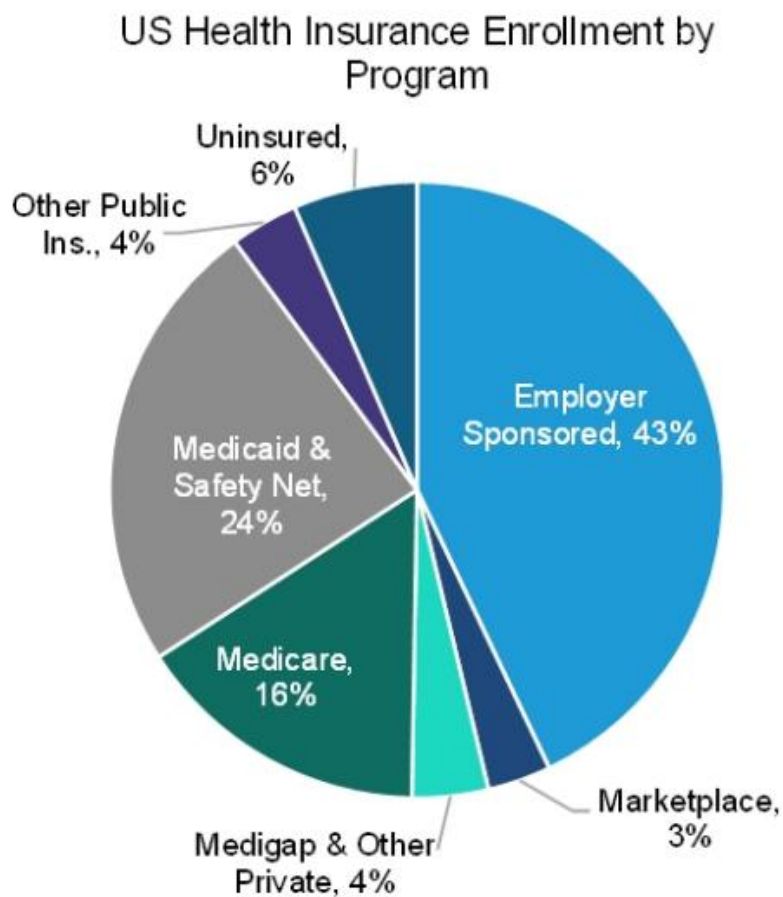
美国主要保险计划 – 支出与参保人数

美国健康保险 - 支出



图表 1

美国健康保险 - 参保人数



图表 2

来源：CMS、NHE 和Bernstein分析

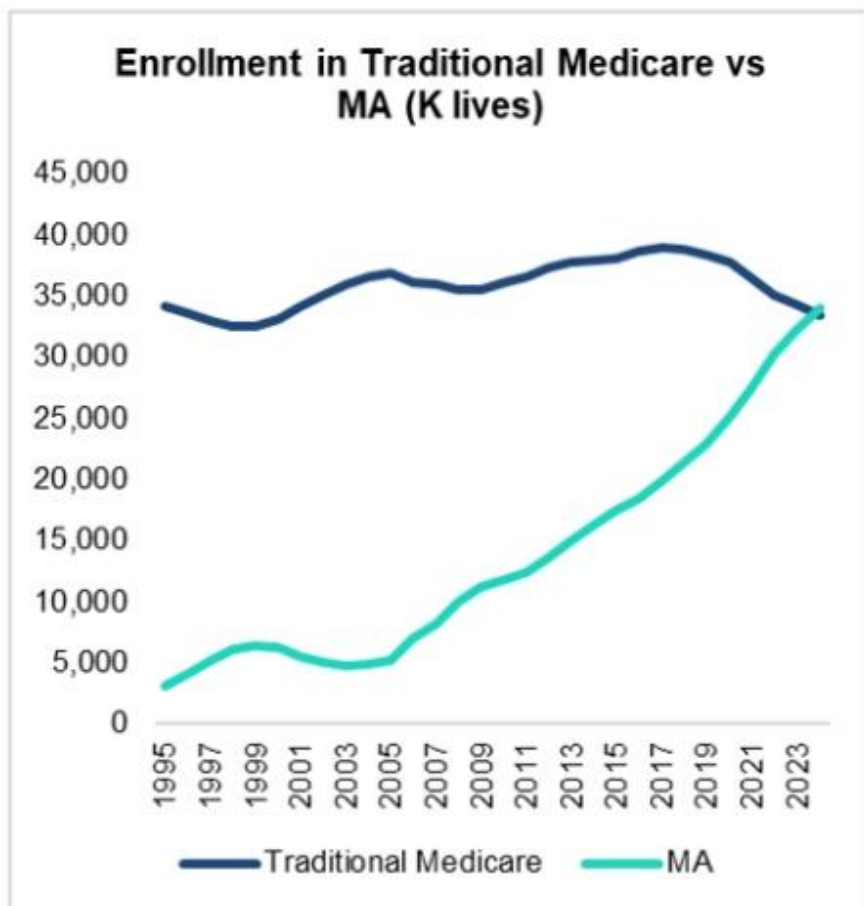
Medicare 约有 7000 万参保人，其中 90% 为 65 岁或以上，其余为残疾人。Medicare 人口是一个不断增长的人口群体，年龄进入增长率约为 5.5%，死亡率约为 4.5%。预期寿命的延长（可能受 GLP-1 影响）将成为 Medicare 成员增长的有利因素。自 1990 年代以来，Medicare 人口的增长几乎全部来自 Medicare Advantage，而传统 Medicare 则保持平稳。

图表 2：MA 市场规模

Medicare 约有 7000 万参保人，其中 90% 为 65 岁及以上

- Medicare 参保人数 – 7000 万 • 65 岁及以上 90%；残疾人 10% • MA 51%；FFS 49% • 年龄段：65-74 岁 52%，75-84 岁 35%，85 岁以上 12% • 平均死亡率 4.5% • 年龄进入增长率 - 约 5.5% • 预期寿命增长
 - 历史上每十年 +1.8 年
 - 近期美国经验每十年 +0.6 年
 - GLP-1 可能每十年额外增加 +1 年

过去几十年来，Medicare 的增长大部分来自 MA



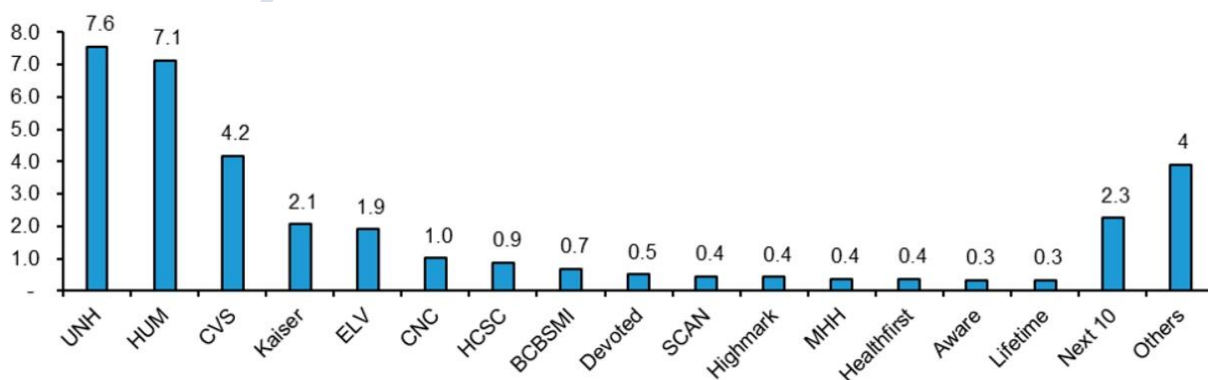
图表 3

来源：CMS, Bernstein分析

UNH 是 MA 领域最大的参与者。UNH 和 HUM 十年来一直位居第一和第二，CVS 稳居第三。该领域还有大量其他竞争对手，三大巨头约占市场份额的 55%。这是一个相对分散的市场，但我们的长期观点是该行业将变得像公用事业一样，拥有 4-6 家大型规模化参与者。

图表 3：Medicare Advantage 的主要参与者

主要 MCO 的 MA 会员数



图表 4

前 10 名包括：Alignment、Corewell、Medica、Guidwell

Mutual、UPMC、MOH、BCBSTN、CuraCor、Clover、Independence Health

来源：CMS、公司报告、Bernstein分析

MA 产品、分销和价值主张

MA 的价值主张。通常，传统 Medicare 支付 80% 的医疗费用，患者支付 20%。成员必须购买独立的药品保险和补充保险来支付剩余部分。MA 计划涵盖这些额外费用，通常设有自付费用上限，并提供视力、牙科和助听器等补充福利。

图表 4：传统 Medicare 与 MA 对比

传统 Medicare

医疗保障

A 部分 – 医院保障 B 部分 – 医生保障

价格/结构

- A 部分零保费；B 部分月保费
- 80% Medicare / 20% 患者

Medicare 补充保险

- 老年人可以购买 Medicare 补充保险来支付其自付部分并限制财务风险

药品

老年人可以购买 D 部分保险

Medicare Advantage

医疗保障

A 部分 – 医院保障 B 部分 – 医生保障

药品

包含在 MA 计划中 (MAPD)

其他福利

- 视力、牙科、听力
- 非处方药津贴

价格/结构

- 成员通常限于网络内提供者
- 最流行的形式是零保费计划
- 手术的自付费用或共保额
- 医疗服务年度自付费用上限为 8,850 美元

来源：Bernstein 分析

财务要素通常是消费者最优先考虑的购买标准。65-70% 的 Medicare Advantage (MA) 市场保费为零，其余市场通常保费较低。消费者第二个关注点是他们偏好的医疗服务提供者是否在网络内，这可能是部分老年人选择不加入 MA 的原因。现金卡、眼科和脊椎按摩等补充福利也是决定消费者满意度的重要因素。品牌和评级的重要性较低，但星级评定可能是影响计划免赔额或补充福利的主要决定因素。总体而言，消费者对 MA 的满意度高于商业保险。这可能是因为 MA 的月保费和免赔额较低。MA 与按服务收费 (FFS) Medicare

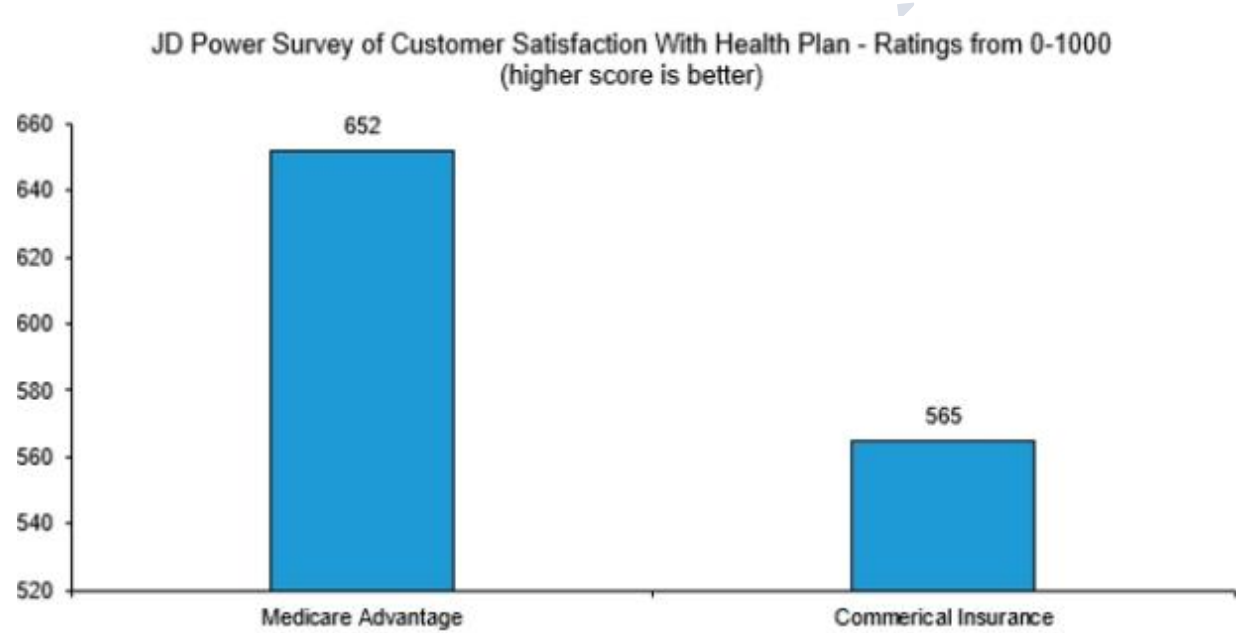
之间的消费者满意度调查显示，满意度评分相当，事先授权和网络限制是消费者对 MA 的主要投诉。

图表 5: MA 计划购买标准

购买标准

- 保费
- 自付费用 • 我的医生和药品是否在网络内？（网络 and 处方集）
- 保障细节
- 补充福利
- 品牌和评级

满意度调查



图表 5

来源：JD Power 调查；联邦基金调查；Bernstein 分析

MA 最常通过经纪人销售。我们估计约 40% 的销售通过电子经纪人完成，约 30% 通过传统经纪人完成，其中一部分经纪人市场是管理式医疗组织（MCO）的内部经纪部门，其余大部分销售通过 MCO 呼叫中心完成。客户群体由个人（约 60%）、团体（约 20%）和双重资格（Medicare/Medicaid）（约 20%）组成。团体 MA 成员可通过前雇主获得退休福利。当我们前瞻性地思考 MCO 市场的赢家和输家时，客户群体之间的差异变得更加重要。例如，对价格敏感的购物者可能对提供现金卡的计划感兴趣，而其他客户可能只专注于维持他们的医生网络。

图表 6: MA 市场进入策略

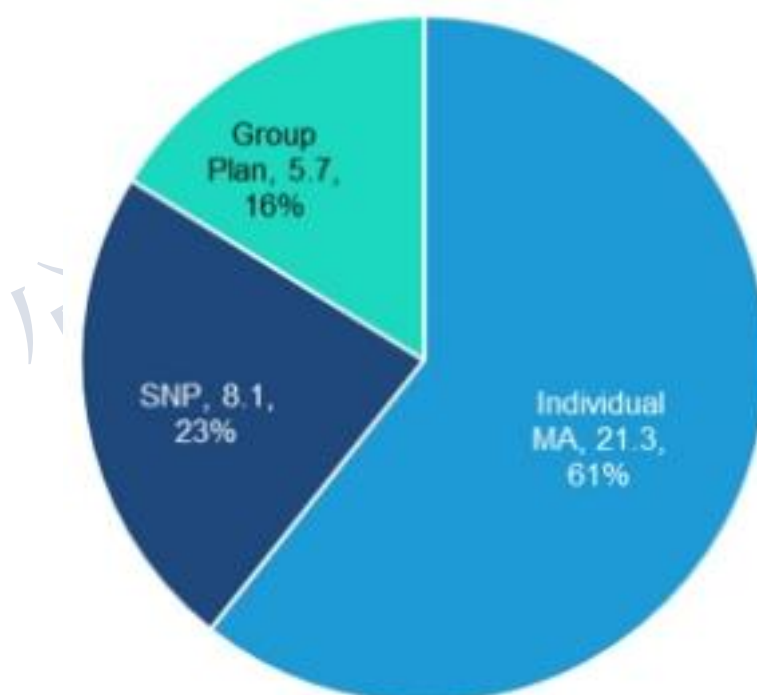
分销渠道通常包括经纪人

Estimated MA Plan Sales Distribution



图表 6

客户群体 · 个人、团体、双重资格



图表 7

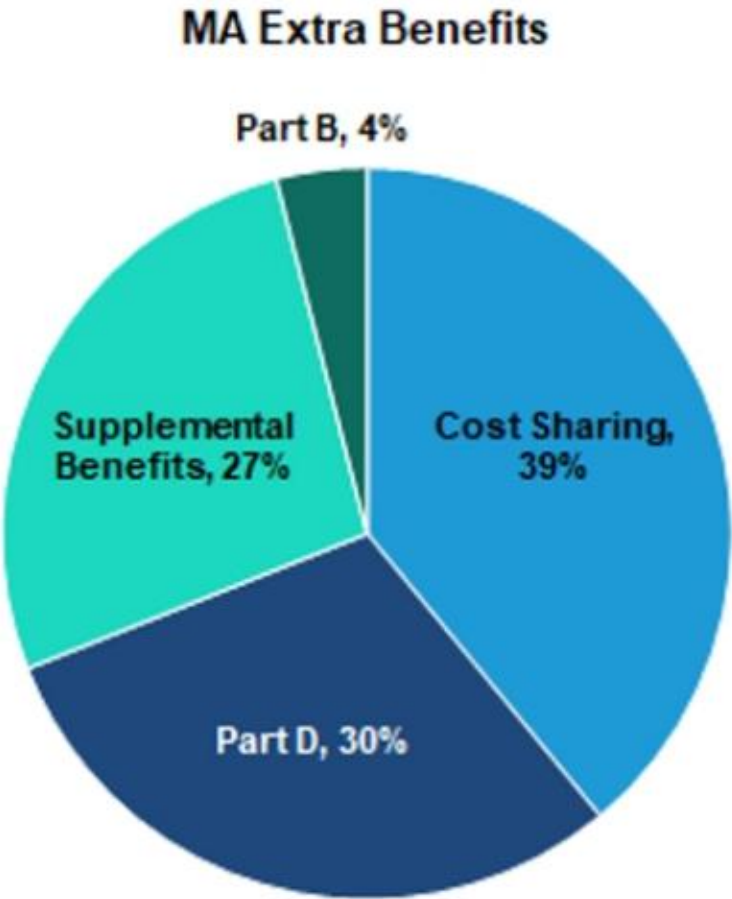
- 客户群体
- 价格敏感型购物者 · 网络忠诚者
- 福利最大化者
- 慢性病成员
- 品牌信赖者

- 便利性

来源：Bernstein估计与分析

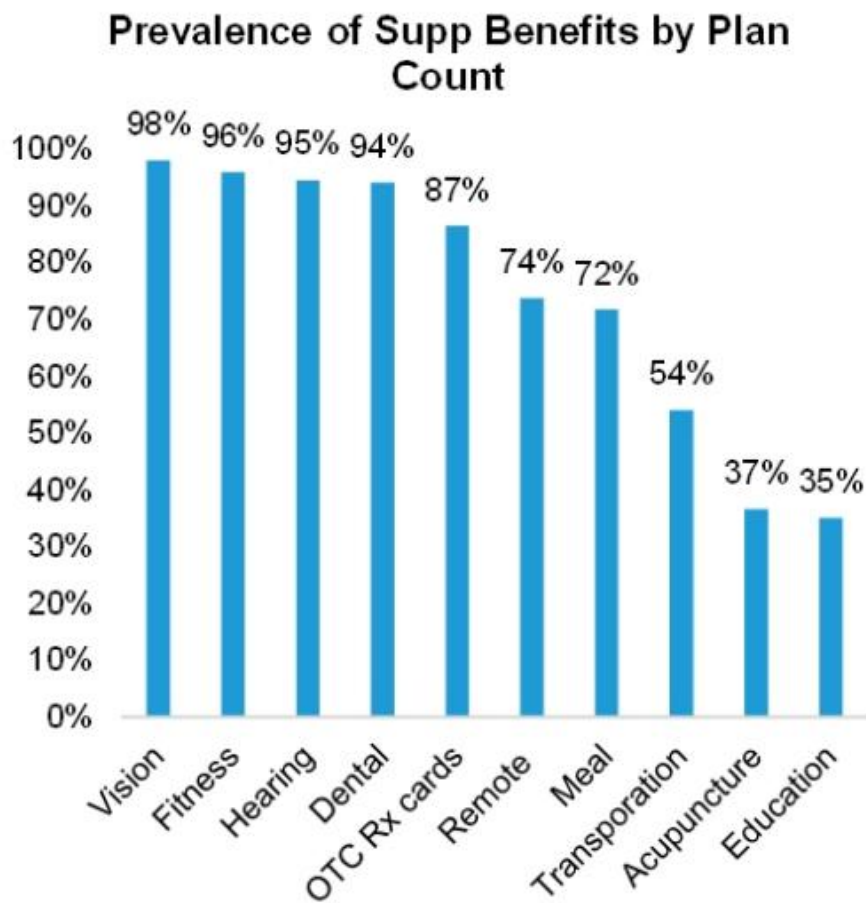
图表 7: MA 为老年人提供的额外福利

2024 年，MA 成员平均每月获得 194 美元的额外福利



图表 8

补充福利是传统 Medicare 中没有的额外福利



图表 9

来源：CMS 与Bernstein分析

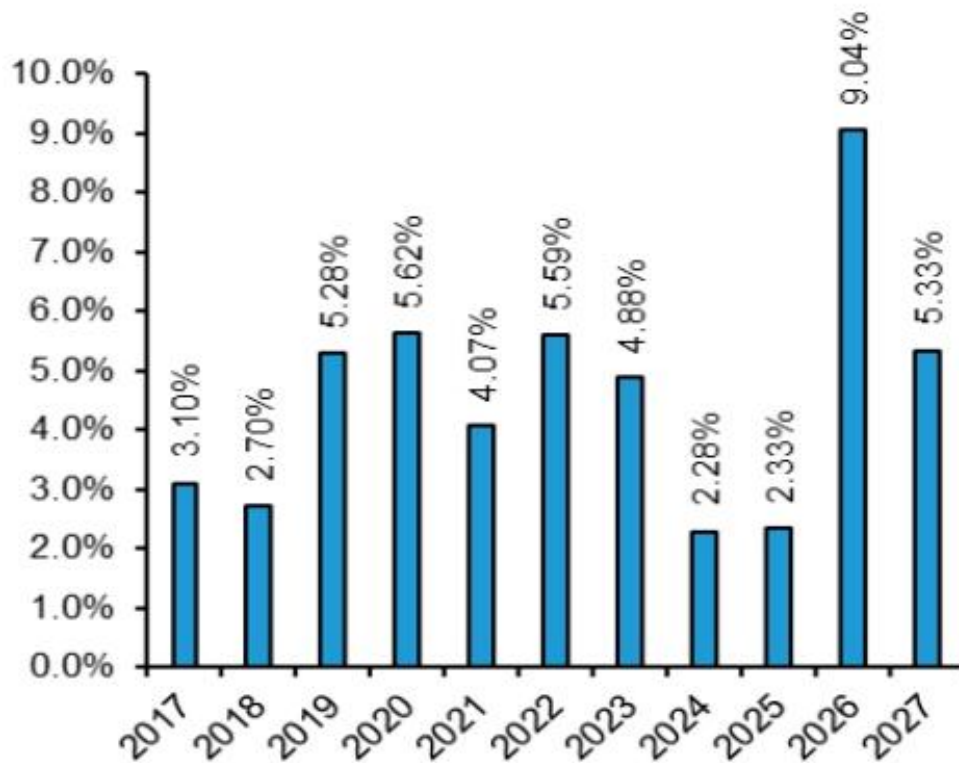
医疗成本与 MA 费率

成本趋势的增长速度快于 MA 费率的增长，这是 2023、2024 和 2025 年 MA 表现不佳的主要原因。CMS 每年公布医疗成本增长率，约为 4-5%。Medicare A 部分（住院）成本在疫情前趋势约为 2.5-3%，疫情后因工资通胀和利用率上升而更高。B 部分（门诊）成本高于 A 部分。结合住院和门诊费用，成本趋势平均约为 4-5%，如图表 8 所示。

图表 8: MA 医疗成本趋势

MA 有效增长率——应代表趋势

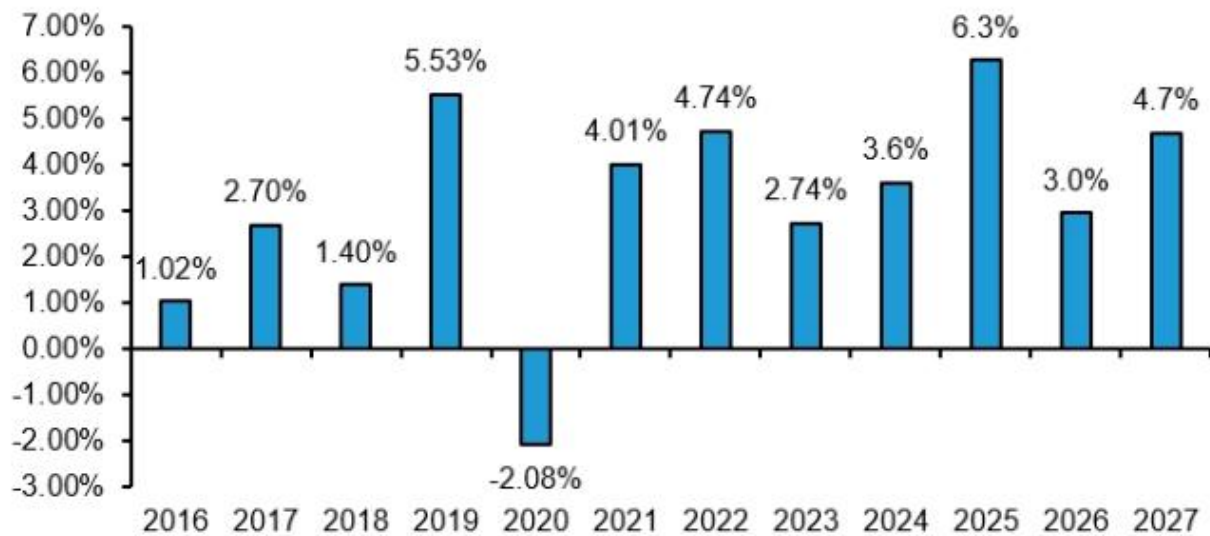
MA Rate
Effective growth rate as per final notice



图表 10

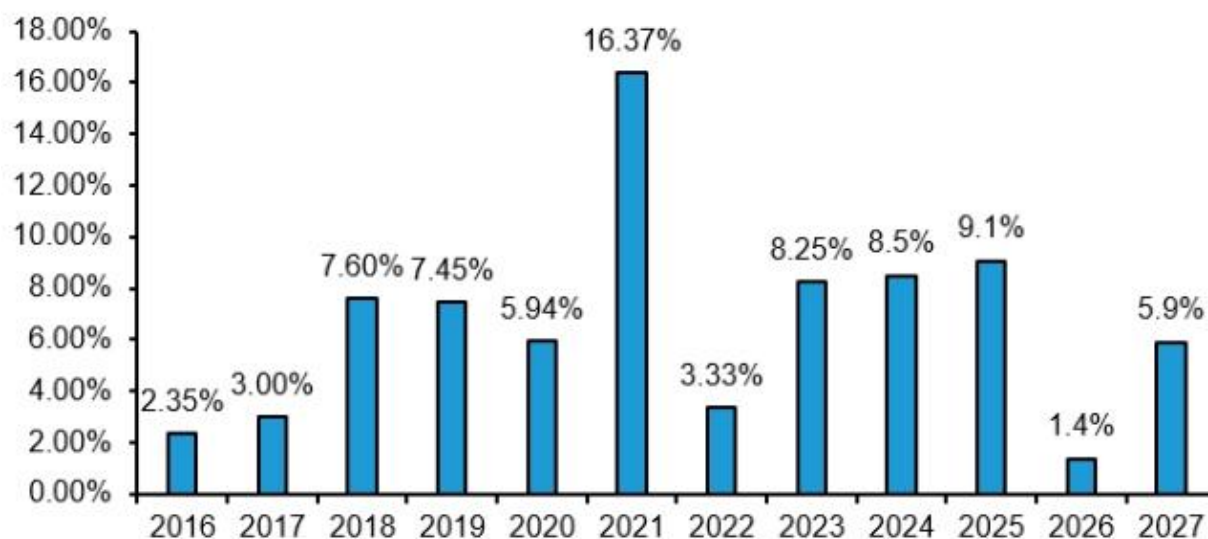
在 24/25 年期间，我们认为有效增长率低估了医疗成本趋势。

Medicare FFS Cost Trend - Part A



图表 11

Medicare FFS 成本趋势 - B 部分



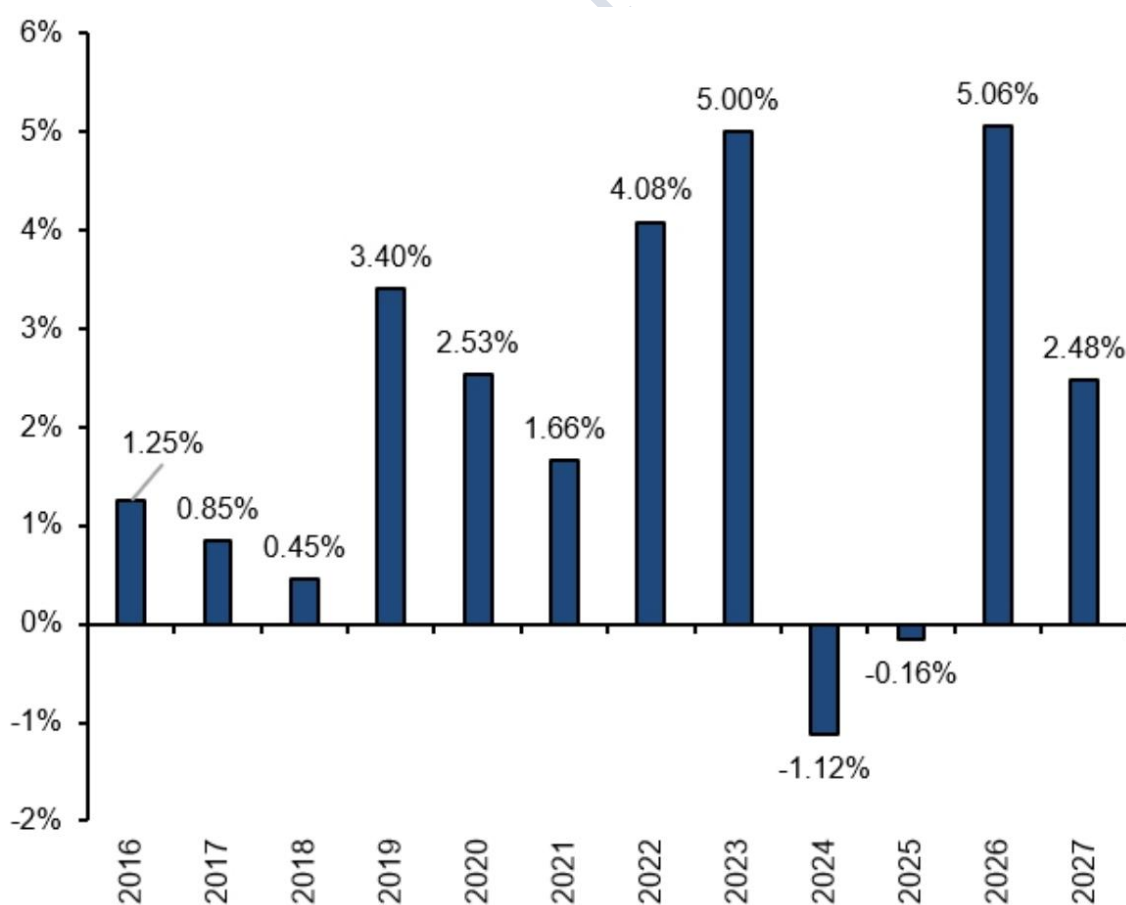
图表 12

来源：CMS 与Bernstein分析

MA 费率每年都有所不同，通常由支付不足或追赶费率的阶段驱动。长期来看，MA 费率往往在 2.5% 左右，而趋势平均约为 4.5%，因此费率通常低于趋势约 2 个百分点。费率在民主党执政期间往往较低，在共和党执政期间较高（费率通常滞后于执政期 3-4 年）。

MA 最终费率

MA 最终费率， %



图表 13

来源：CMS, Bernstein分析

MA 费率构成。CMS 通常在每年 2 月 1 日左右发布初步费率通知，4 月 1 日左右发布次年最终通知。有效增长率是医疗成本趋势，如图表 10 第一行所示。然后，有一系列调整，包括基数重置、风险模型修订（v28）和星级评定。MA 费率通常不包含风险评分。风险评分是加项；它是 MCO 因承保风险较高人群而获得的收入。理论上，MCO 因承保高风险患者群体而产生的额外成本应由风险评分抵消。

2023 年通知

年度支付百分比变化

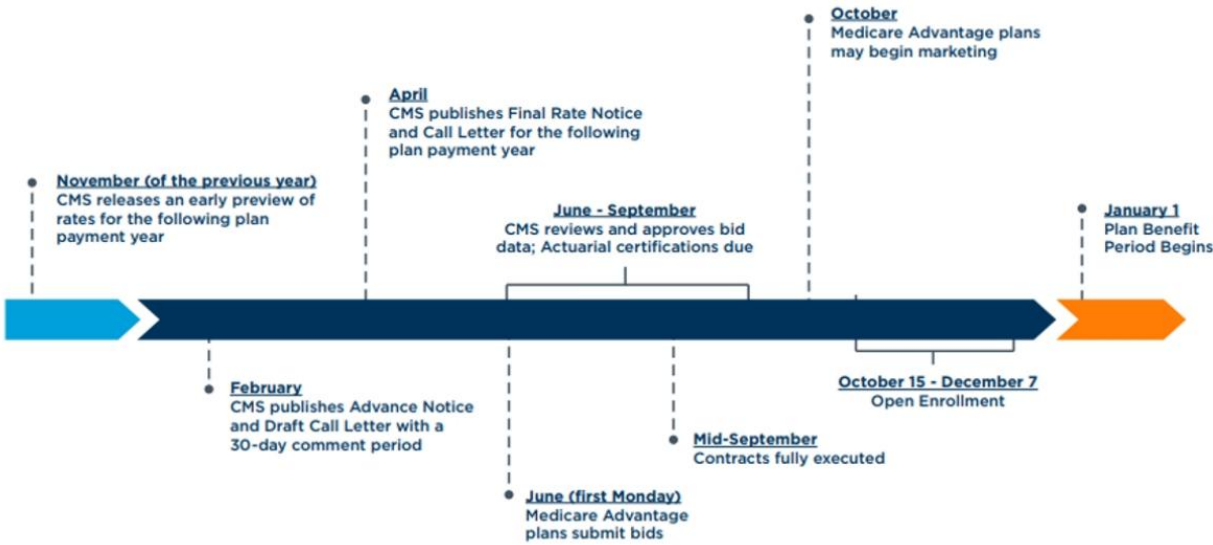
2024 年通知

年度支付百分比变化

来源：CMS，Bernstein 分析

费率通知和成本趋势评估在计划生效前一年完成。2 月发布初步费率上调，4 月发布最终费率。费率可能因地区而异。MCO 全年观察趋势，MA 计划投标在 6 月初提交。当 MCO 制定计划时，他们在提交投标前会考虑费率上调、成本趋势和期望的产品特性。计划在 10 月最终确定，公开注册从 10 月 15 日开始，供成员选择计划。在计划年度内需要监控的主要因素是计划变更是否引入了逆向选择偏差，以及利用率是否发生变化。第二季度业绩通常是衡量 MCO 是否会受到福利设计影响的良好指标。

图表 11: MA 年度投标时间表



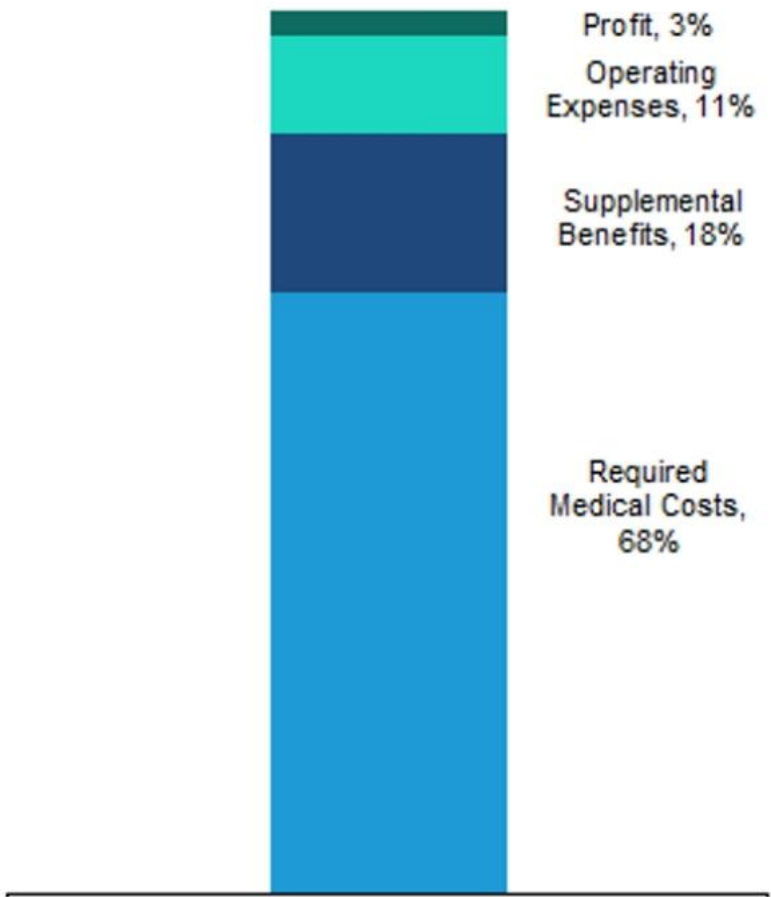
图表 14

来源：CMS，Bernstein 分析

MCO 投标构建。构建投标的公式包括估算医疗成本、确定额外福利和保费水平，以及确定运营成本以定义目标利润水平。普遍认为 MA 比 Medicare FFS 节省约 30%。在 MA 中，节省的资金用于补充福利和运营费用。进入 2026 年，初步通知的费率上调约为 0%。这种利润压缩的一个潜在副作用可能是“缩水式通胀”。这在消费品中可见，制造商缩小包装尺寸。在 MA 行业中，可以通过减少福利和提高免赔额来发生类似机制。MCO 还可以通过价值导向型医疗（VBC）等方式改善成本以提高利润率。这一机制是我们核心论点的基础，即面对持续的利润压缩，VBC 的价值主张将增强。在面临利润压力时，退出无利可图的市场是另一种选择，这可能是实现利润率扩张的快速途径。

图表 12: MCO 如何构建 MA 投标

+ 估算所需医疗成本 + 确定预期保费水平 + 预测竞争对手提供的补充福利 + 确定运营成本和目标利润水平



图表 15

来源：Bernstein分析

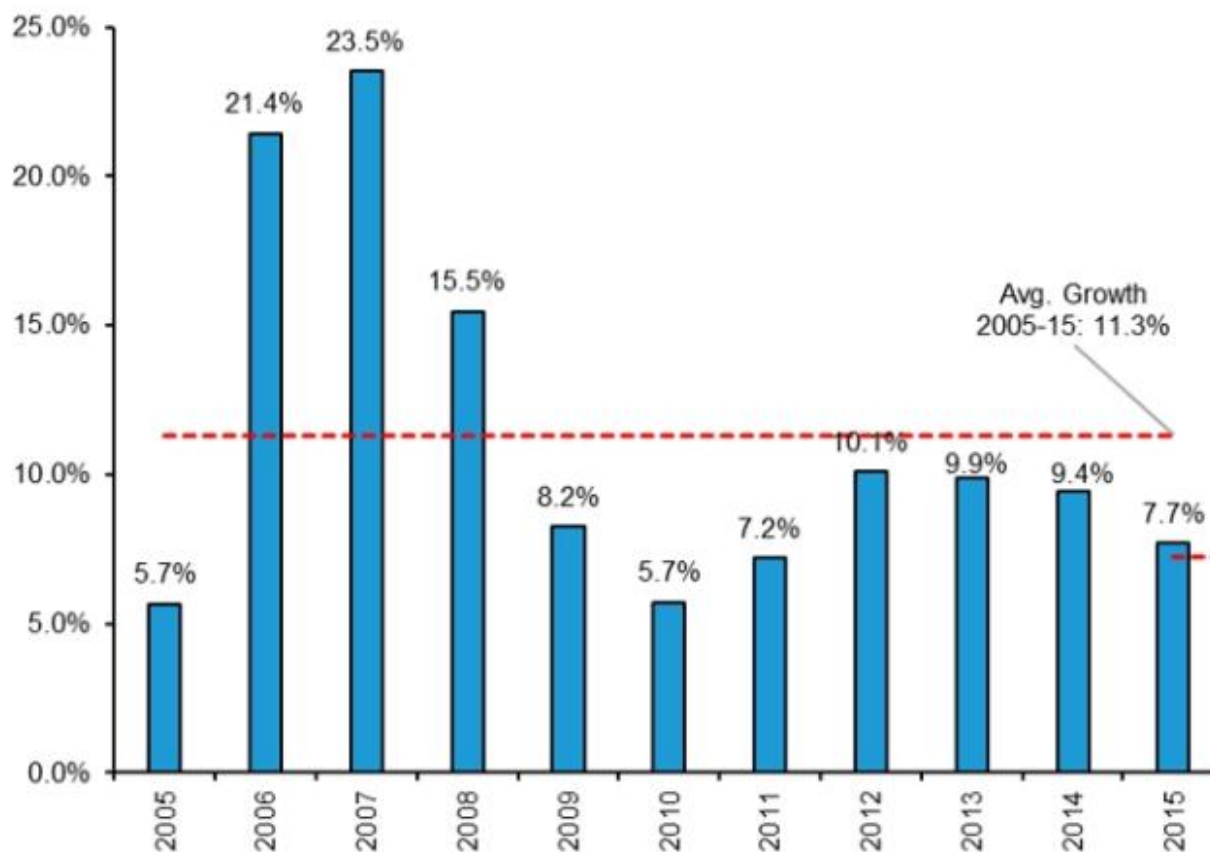
3/5

提升MA收入的杠杆有多种。在雇主等传统业务中，定价纪律涉及提高费率，但在MA中，费率上调主要由政府设定。不过，MA计划仍有若干机制可影响收入。首先是星级评定，它为高质量计划提供奖金；其次是风险调整，它为病情更复杂的患者提供更高的支付。管理式医疗组织（MCO）为加入四星级及以上计划的会员额外获得5%的支付。这些通常以额外福利的形式流出，但也可以成为改善利润率的杠杆。此外，MA计划可以通过退出某些市场或产品、削减福利、提高免赔额、通过网络管理引导患者选择成本更低的医疗服务提供者以及降低运营成本来影响其产品成本。

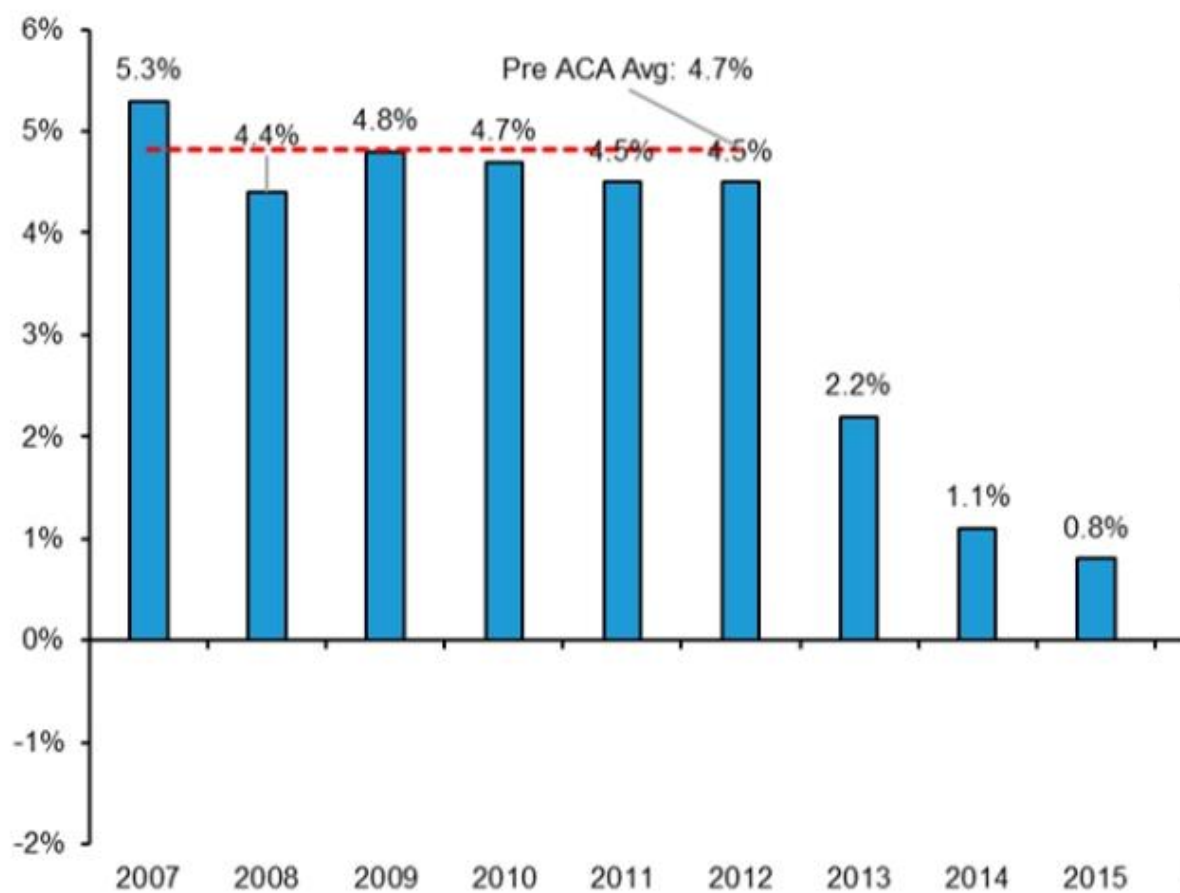
近期MA绩效危机的驱动因素

图表13：MA会员增长

MA在早期增长非常强劲



图表 16



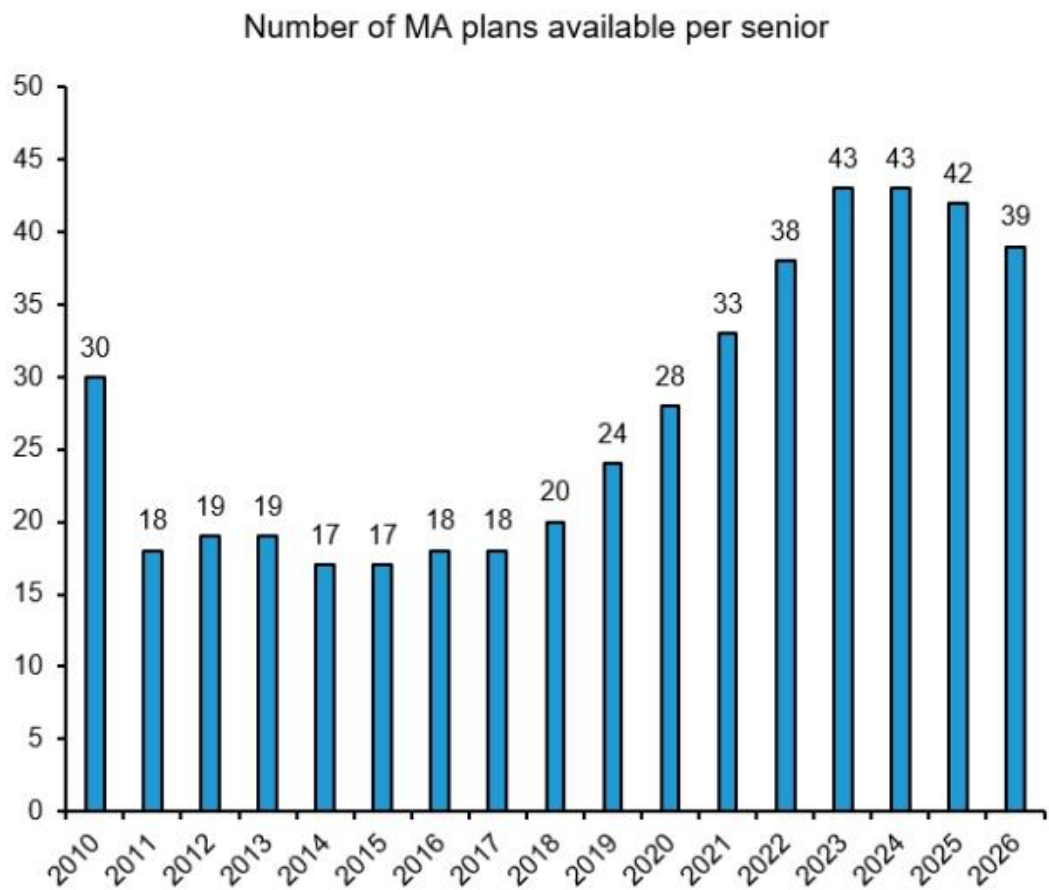
图表 17

来源：CMS、Medicare受托人报告、Bernstein分析

每位老年人可选择的MA计划数量从2011年到2023年翻了一番。我们估计，在2000年代末，每名老年人有3家公司竞争，到2018年增至每名老年人6家公司，2023年达到每名老年人9家公司。随着竞争加剧，提供的额外福利金额也随之增加。从2010年代中期到2020年代中期，额外福利的美元价值增长了一倍多，给MA利润率带来压力。这导致传统Medicare参与者更加关注增长，而雇主和Medicaid MCO等非传统参与者则扩张进入MA以获取这一增长机会。

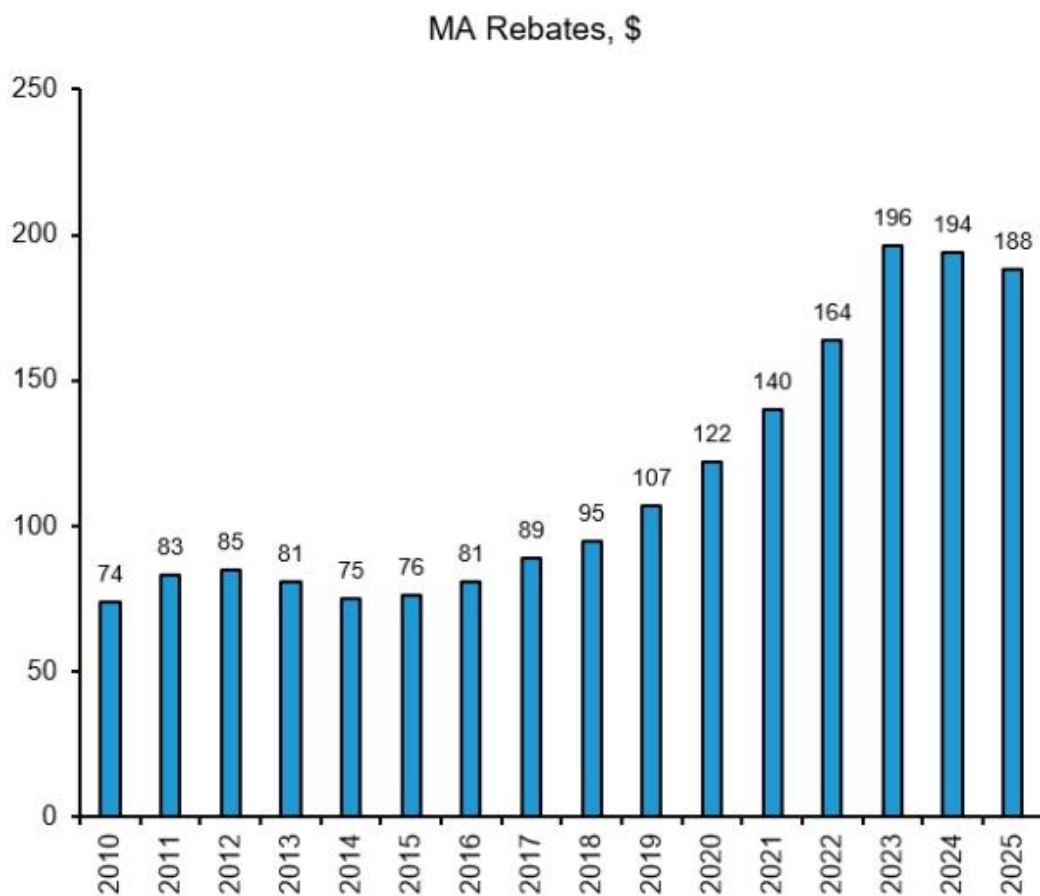
图表14：Medicare营业利润率

这种增长和利润率状况吸引了竞争者



图表 18

并且计划增加了为老年人提供的额外福利以扩大市场份额



图表 19

来源：KFF、Bernstein

图表15：MA会员增长

MA会员持续增长，但由于基数变大，百分比增速放缓

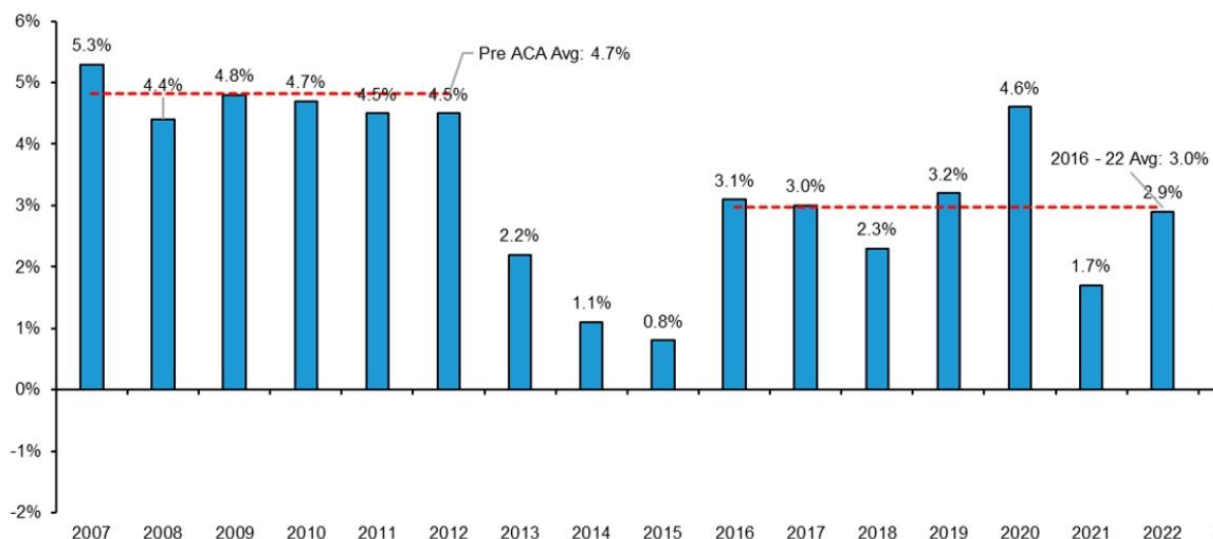


图表 20

来源：CMS、Medicare受托人报告、Bernstein分析

图表16：Medicare营业利润率

利润率从约5%压缩至约3%



图表 21

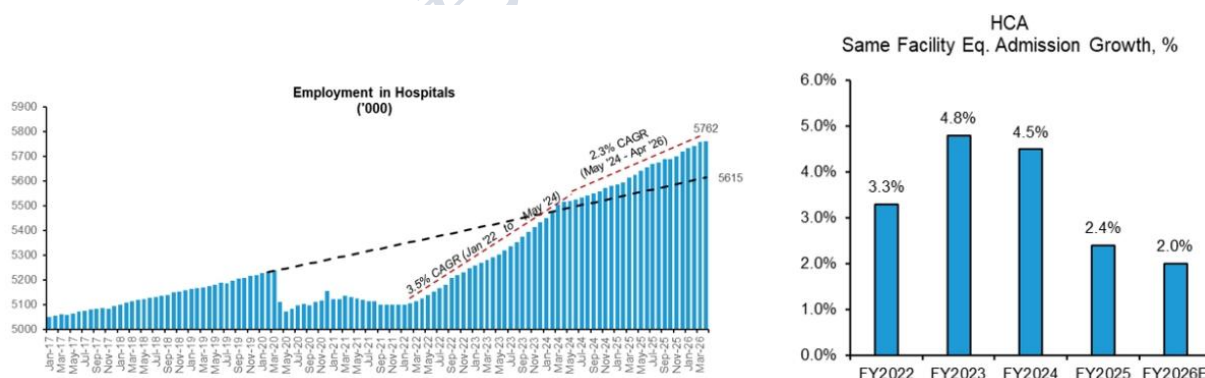
来源：NAIC、Bernstein分析

近期危机

2023年，我们看到了与新冠疫情相关的供给冲击的残余影响。随着时间的推移，医院就业增长与同一机构的入院人数增长密切相关。2020年第三和第四季度经历了供给冲击衰退，医疗行业的就业反弹速度慢于其他行业。医院就业在2022年开始反弹，医院就业增长率比历史常态高出1-1.5个百分点，导致医院业务量强劲增长。利用率的显著增加在2023年影响了MCO的利润率。近年来，医院就业已超过其历史趋势线，导致招聘放缓，随后利用率恢复正常，这为2025年以及似乎2026年的MCO创造了顺风。

图表17：利用率周期是2023年的重大影响

供给冲击影响产能 产能增长的追赶在2023/2024年令MCO措手不及



图表 22

来源：BLS、HCA、Bernstein分析和估计

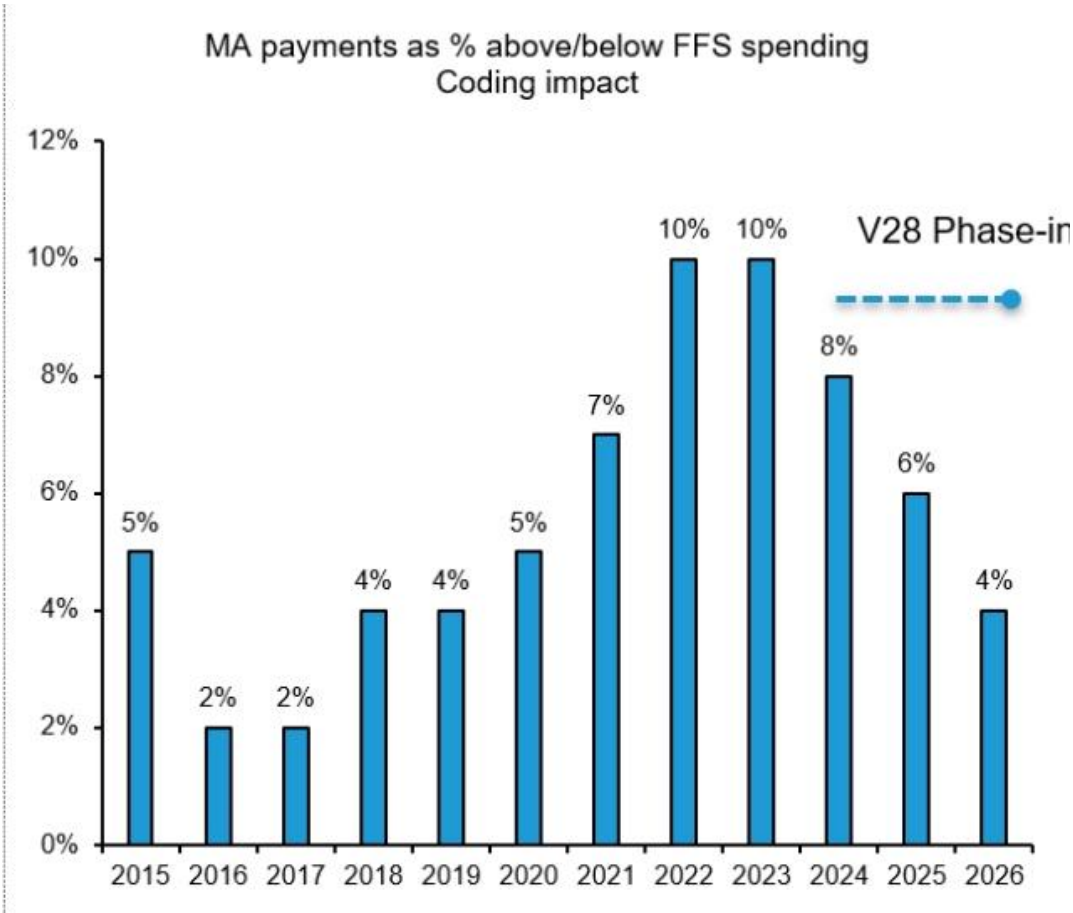
在过去几十年里，我们每12-15年就会经历一次Medicare支出冲击——克林顿时期的1997年《平衡预算法案》和奥巴马的《平价医疗法案》是最近推动这一趋势的立法。通常这些费率冲击会持续2-3年，之后通过削减老年人福利或减少医疗服务提供者供给带来的痛苦导致费率正常化。与以往政策影响相比，拜登行政行动的迅速性不同寻常。这些是行政行动，而非立法行动，因此它们比之前的国会法案发生得更快。拜登的行政行动于2022-24年颁布，并在2024-25年开始产生影响。

图表18：Medicare/MA改革历史 影响Medicare和Medicare Advantage的主要立法

来源：Bernstein分析

拜登的行政行动是由对过度编码的担忧驱动的。有一种看法认为，过度编码导致2022-23年多支付了10%，因此v28被分阶段引入，以在3年内将风险调整减少约6%。2027年的费率将这一过度编码再减少1.5%。

风险调整在2022-23年导致10%的多支付 v28分阶段实施将风险调整影响在2026年降至4%



图表 23

来源：MedPAC、Bernstein分析

MA风险调整如何运作以及v28的变化

- 基本前提是，MA计划应获得更多支付，以管理患有更昂贵疾病的会员。

CMS于2023年引入v28，将在三年内分阶段实施。

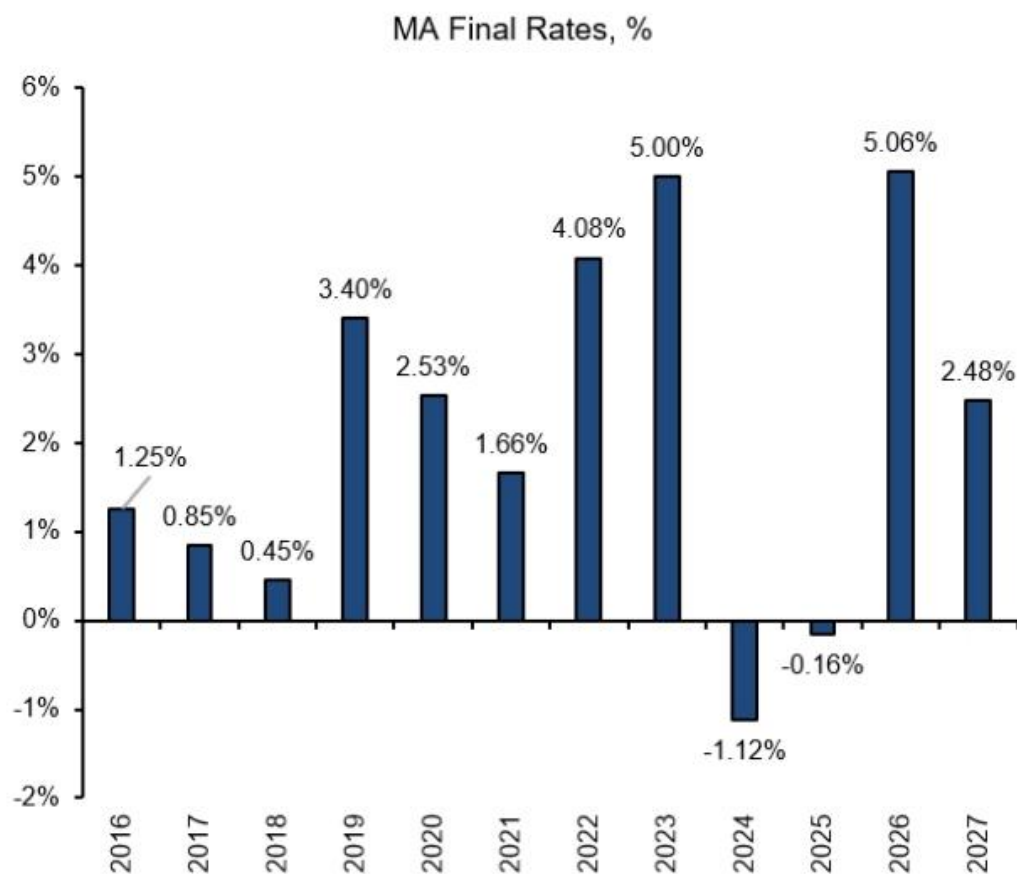
- 约束过程 - CMS还决定在新模型中不纳入那些条件不能准确预测成本的HCC。

- 这些变化的净影响是，自2023年以来（CY26是过渡的最后一年），保费每年面临2-3%的不利因素（反映在较低的MA费率中）。

对过度编码的担忧导致2024/2025年MA费率较低。低有效费率是行政机构削减费率的努力，并与v28中风险调整公式的变化相结合。

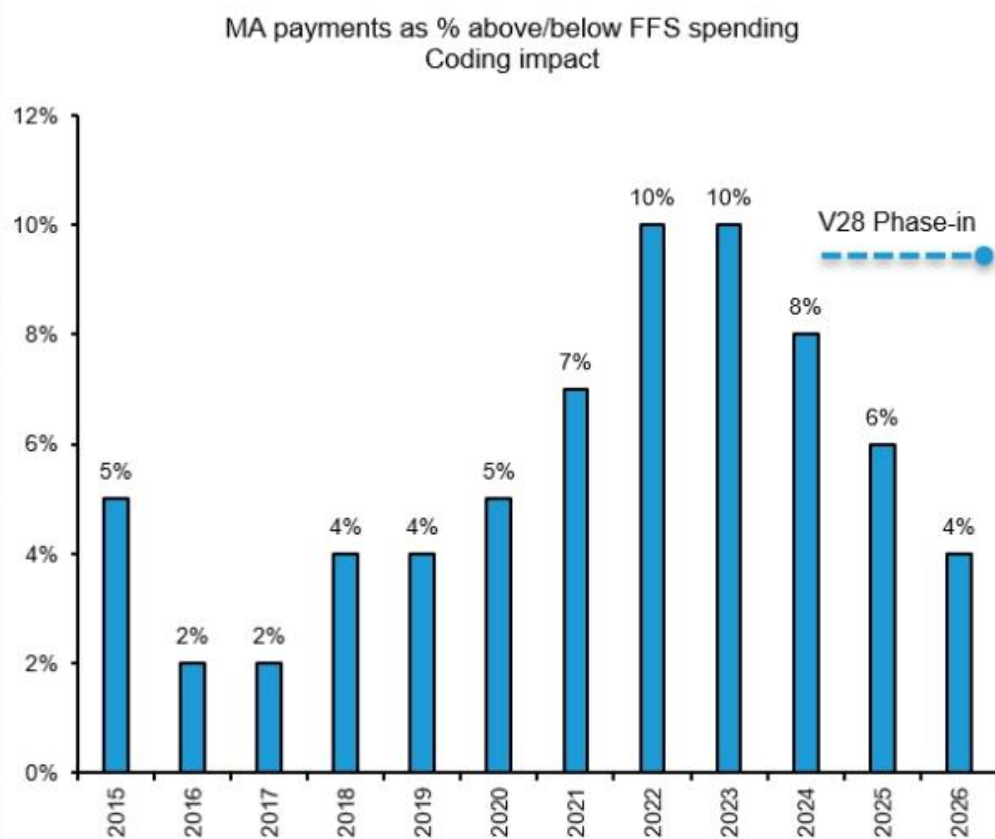
图表20：MA费率

MA最终费率



图表 24

V28解决过度编码问题

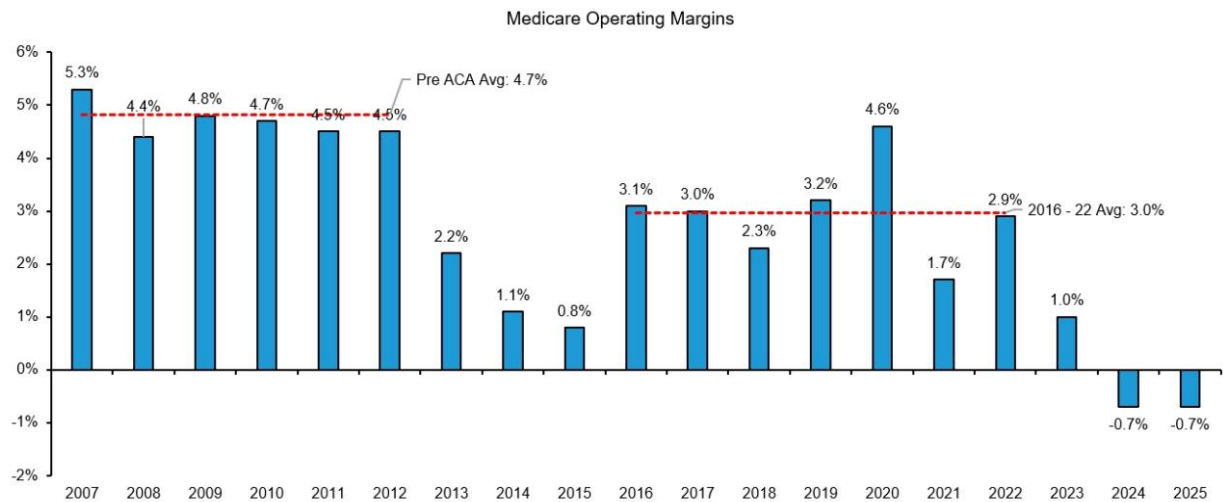


图表 25

来源：CMS、MedPac、Bernstein估计和分析

行业利润率自2022年以来下降了360个基点。过去三年利润率持续压缩，竞争激烈的市场在2023年遭遇了疫情后意外的利用率激增，而24/25年的低费率和风险调整政策变化进一步压低了利润率。我们看到2023年下降了190个基点——这主要是由于疫情后利用率上升导致的错误定价。我们注意到，从2025年开始的定价纪律和竞争退出使得利润率在低费率和v28实施的情况下得以稳定。我们预计2026年行业利润率将有所改善，并预计2027年MA利润率将增加，但考虑到MCO对2027年定价纪律的评论，增速将慢于2026年的改善。

图表21：Medicare营业利润率



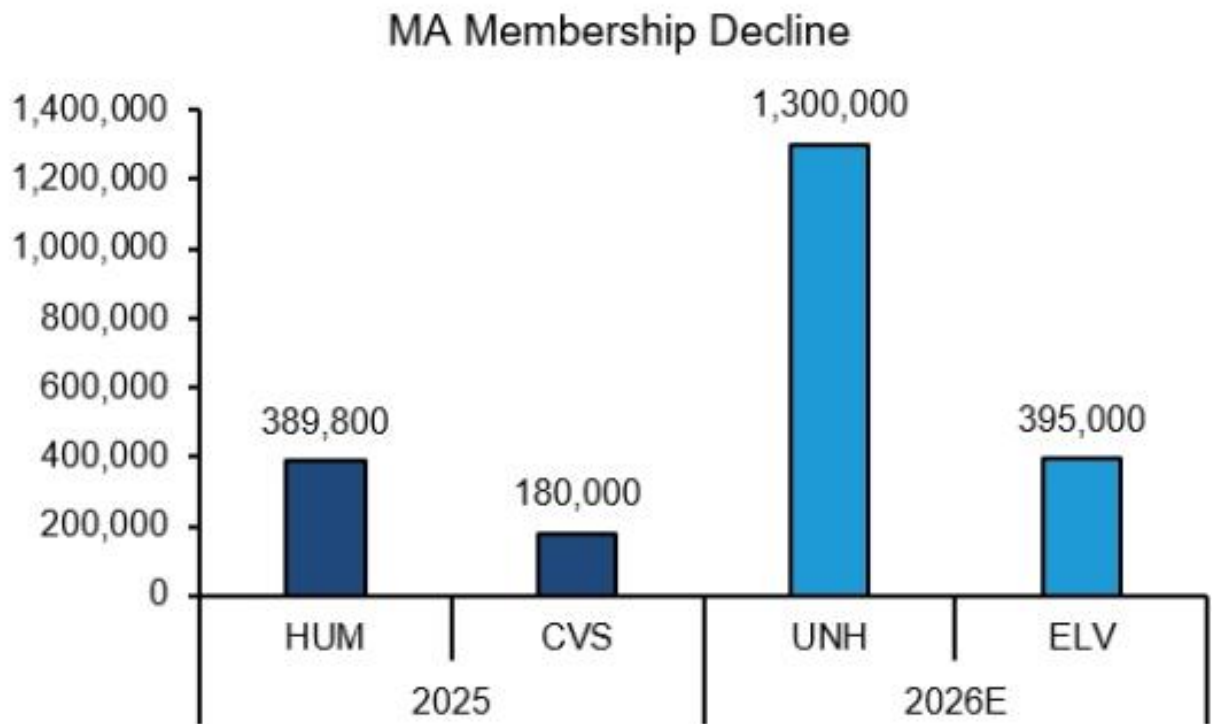
图表 26

来源：NAIC、Bernstein分析

当前环境与展望

随后，行业出现了竞争退出的情况。HUM和CVS在2025年减少了MA会员，随后UNH和ELV宣布在2026年减少会员。竞争对手也已退出，包括CI、MOH以及几家蓝十字和非营利组织。

图表22：MA竞争退出 四大MA会员数量下降



图表 27

来源：公司报告、Bernstein分析

MA退出情况

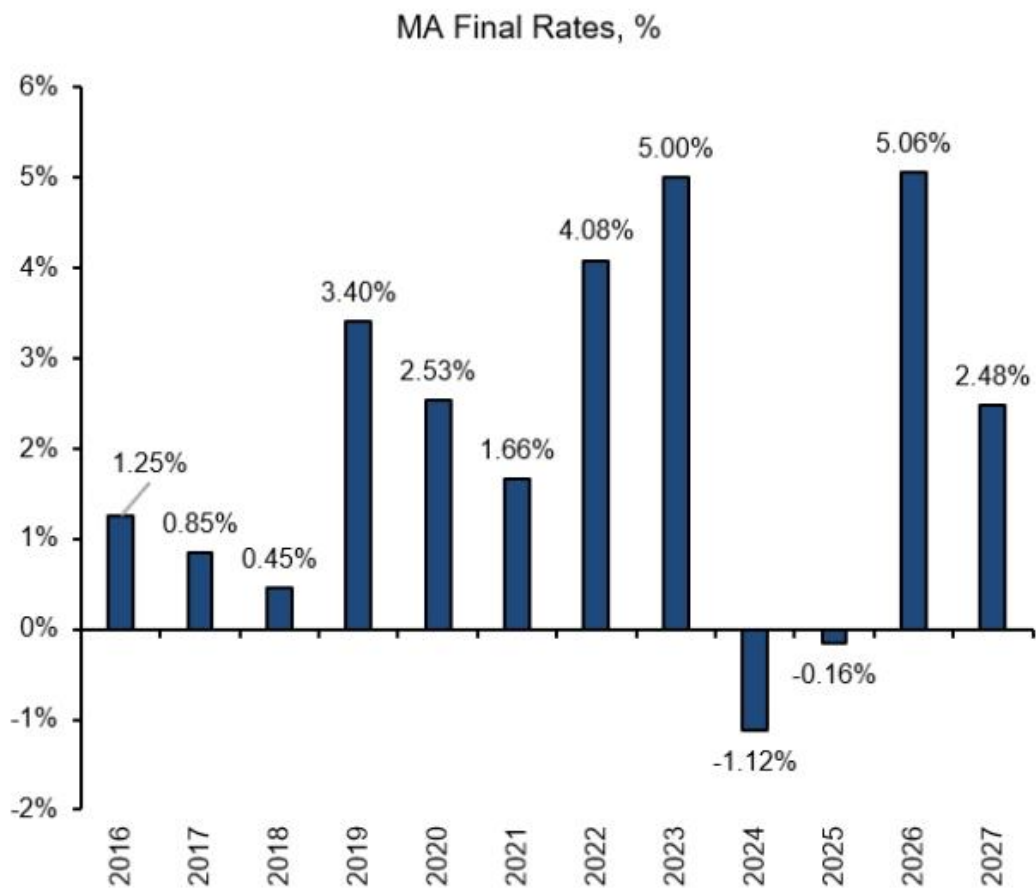
- Cigna
- Molina (退出MAPD)
- Premera Blue Cross (退出华盛顿州) • 堪萨斯城BCBS • 佛蒙特州BCBS (2026年退出)
- Ucare (明尼苏达州/威斯康星州)

此外，该行业的费率和利用率已趋于正常化。2026年费率上涨5.06%，而2027年2.48%的费率涨幅符合我们对长期正常费率的看法。2027年2.48%的费率包含了对非关联图表审查的改革，这使得2027年的超额风险编码又降低了1.5%。2027年的费率识别出，但未调整，另外超过2%的潜在风险编码调整，而是将调整推迟到基准年。关键在于，MA中似乎仅剩2.5%或更少的过度编码（而2023年为10%），这也降低了未来几年的费率风险。

我们看到医疗量的利用率模式正回归至疫情前水平。对于MCO而言，这与近期经历相比是有利的，且它们主要基于近期医疗成本趋势的经验进行定价。对于医院而言，这是量的逆风，许多医院（如HCA）已将其纳入指引。我们认为，回归更传统的产能增长水平（薪资增长）是这种量正常化的一个主要因素。

图表 23：MA费率在26、27年正常化

MA最终费率



图表 28

利用率似乎正在正常化

资料来源：CMS，公司报告，Bernstein分析

削减福利是改善利润率的另一种机制。补充福利在2023年达到顶峰，并在2024、2025和2026年有所下降。药房方面免赔额的提高导致会员自付费用增加。随着《通胀削减法案》的出台，保费有所增加，该法案使MCO面临更

多的药房成本风险。这一趋势可在下图中观察到，该图显示了HUM第一季度的保费。

福利削减包括免赔额和自付费用增加

D部分免赔额

随着IRA和药房福利的变化，每份保单的保费也有所增加

资料来源：CMS, MedPac, Milliman, HUM, Bernstein分析

UNH已削减MA会员数量，并在2026年第一季度显示出显著的正常化利润率改善。CVS也出现了类似的情况，2026年第一季度MLR改善了200-300个基点。重要的是要理解，MCO在不同政策环境下拥有影响利润率的杠杆。它们可能在强劲的费率环境下亏损，也可能在低费率环境下改善利润率。

（2025年的MLR代表Bernstein对经准备金时间调整后的MLR的看法）资料来源：公司报告，Bernstein分析

鉴于过去几年的波动性，我们观察到了强劲的准备金计提模式。UNH 2026年第一季度的准备金计提是过去8年来最强劲之一。因此，我们认为这是MLR的真正转折，而不仅仅是由于准备金模式带来的暂时性改善。

图表 26：准备金

UNH – 医疗准备金水平

资料来源：公司报告，Bernstein分析

我们认为2025年是利润率稳定的一年。我们预计2026年行业层面将恢复100个基点，且存在更多上行空间。在公司层面，我们预计2027年将改善50个基点，并且这种模式将持续到2030年。我们预计行业将向头部企业进一步整合，利润率较低的参与者将退出。这种动态将使利润率恢复看起来比实际情况更显著。

图表 27：Bernstein对MA利润率恢复的行业估计

预计公司层面的MA利润率在26年改善100个基点，27年及以后改善50个基点

- 利润率上限可能会更低，因为竞争减少导致极低利润率参与者减少

资料来源：NAIC，Bernstein分析和估计

图表 28：Bernstein对行业增长的估计

我们预计MA会员数量的长期增长率为4-5%

资料来源：CMS，Medicare受托人报告，Bernstein分析和估计

未来环境与关键问题

由于过度编码强度，仍有约2.5%的风险调整我们认为最终需要被移除。CMS根据其2月份的分析表示，这可能接近约50个基点。我们预计任何调整都将在数年内分阶段进行，可能通过每年约100个基点的有效增长率削减来实现。CMS也在评估基准年和家庭风险评估的潜在变化。此外，还存在来自风险调整审计和潜在和解的追溯风险。ELV已为其正在进行的关于过度编码的诉讼预留了约10亿美元，而我们之前的估计表明，UnitedHealth的风险敞口在约20-40亿美元范围内。

MedPAC认为，除了编码强度之外，有利的风险选择可能代表了额外约10个百分点的超额利润率。我们不同意这种观点，这一立场最近得到了《华尔街日报》和Paragon的支持。从历史上看，MA可能通过避免高acuity受益人而受益于有利的风险选择，导致约10%的选择偏差。然而，随着MA渗透率现在约为55%，补偿高acuity患者的风险调整机制，以及 enrollment 趋势偏向低收入人群，我们认为显著的选择偏差持续存在的可能性不大。

财政压力仍然是一个重要的背景。医疗保险支出目前约占联邦预算的13%，预计到2032年将上升至约18%。随着医疗保险信托基金预计在2033年耗尽，资金缺口需要通过增加政府缴款或提高受益人保费来解决。因此，我们

预计MA费率增长将持续落后于基础成本趋势约100-150个基点。

随着时间的推移，我们预计CMS将认识到MA相对于FFS的结构性成本较低，这可能支持旨在提高MA渗透率的政策。现任政府已开始评估自动注册等机制，但迄今为止尚未实施正式政策。

图表 29：联邦政策关注领域

资料来源：CMS, MedPAC, 和Bernstein分析

我们认为MCO将变得“像公用事业一样”。在我们看来，该行业将整合为4-5家大型参与者，MA渗透率将增长至100%。作为其中的一部分，我们预计占市场40%的分散部分将流向大型规模化参与者。长期来看，我们预计该行业将拥有低利润率和更高的杠杆率，因为公司试图最大化ROE。我们预计这一转变将在未来约20年内发生。

图表 30：Medicare Advantage计划作为公用事业

政府MCO作为公用事业

- 我们预计政府MCO将变得像公用事业一样，
- 我们预计MA渗透率将增长至100%，包括管理一小部分FFS业务
- 我们预计Medicaid将外包剩余支出，占当前支出的40%以上
- 我们预计低利润率（Medicaid为1.5%，Medicare为2-3%）
- 我们预计每个业务领域只有4-5家全国性大型参与者

资料来源：Bernstein分析

我们主张，MA（联邦医疗保险优势计划）将转向VBC（基于价值的护理）模式。目前，约三分之一的MA治疗是在基于价值的护理模式下提供的。纯VBC模式的替代方案是以VBC为中心的模式，包括Clover Health，这些模式将VBC的原则分解并保留在MA计划内。这些模式试图吸引医生并赋能医生，使其能够实现与VBC相同的目标，但不是通过风险转移，而是通过奖金支付或按服务收费来支付额外服务。MA计划协助协调医生在传统VBC模式下需要协调的任务。我们认为，这使得MA的持久性更高，因为它不太可能被VBC纯粹地去中介化。

图31：VBC与以MA计划为中心的赋能模式

资料来源：Bernstein分析

GLP-1类药物及其他药品类别使用率的提升将推高承保成本，这体现在药房支出成为成本趋势中增长更快的组成部分。GLP-1类药物还有可能延长预期寿命，这可能会使联邦医疗保险（Medicare）的参保人数额外增加5-10%。

图32：GLP-1的颠覆性影响

GLP-1的影响

- 随着时间的推移，GLP-1类药物很可能被联邦医疗保险覆盖
- 这将带来近期的成本波动，而示范项目持续时间越长，这种波动就越小
- 承保成本的增加将推高保费
- 预期寿命预计在二十年内增加0.5至2年，
- 这表明在一到二十年内，联邦医疗保险市场参保人数将增加5%至10%

资料来源：Bernstein分析

人工智能未来将产生重大影响。人工智能将通过改善支付方运营和效率来降低运营费用。在消费者方面，人工智能代理可以促进并改善患者的治疗效果。

图33：人工智能将对包括MA在内的医疗保健产生重大影响

资料来源：Bernstein分析

我们认为，垂直整合仍将是政策审查日益关注的领域，尽管我们认为强制分拆的可能性相对较低。更现实的风险是，立法努力实际上“叠加”医疗损失率（MLR）或限制关联实体的利润率，这将削弱维持整合结构的经济理由。在这种情况下，传统的管式医疗组织（MCO）和VBC业务很可能是首先受到关注的领域，可能导致这些业务板块的选择性分离。

重要的是，我们不认为这本质上是负面的。在某些情况下，分离可以释放价值，或使业务能够更专注地运营。例如，我们可以设想一个场景，即联合健康集团（UNH）的VBC平台作为独立实体能够实现更快的增长。

展望未来，2028年大选是一个关键的政策不确定因素。从民主党的角度来看，我们预计其主要焦点将集中在将覆盖范围扩大回峰值参保水平。到2028年，未参保率可能徘徊在约9%的水平，将其降低回约5%的更正常水平很可能是一个核心政策优先事项，尤其是在人工智能可能造成就业冲击的背景下。

虽然“全民联邦医疗保险”（Medicare for All）仍然是更广泛系统改革的概念框架，但近几个周期的政治关注点更紧密地与可负担性和可及性相关。我们预计这些主题，而非全面的系统改革，将主导政策辩论。尽管可能会出现一位支持“全民联邦医疗保险”的候选人，但我们认为，扩大覆盖范围最终将成为2028年大选周期中定义医疗保健议题的核心问题。

图34：未来政策议题

资料来源：Bernstein分析